

3 - 03- Le cancer de la langue - Pr. Rochdi

(0:00 - 0:20)

Concerné à notre concert de voies aériennes législatives supérieures, c'est le concert de la Nantes. Le concert de la Nantes fait partie du concert de la capitale du Cap. Le concert de la capitale du Cap, ça veut dire le concert de la Nantes, le concert du Cap, le concert de Jancy, le concert de la Saint-Anne de l'Avion, le concert d'Ellen.

(0:22 - 0:48)

Dans cette une des zones, il y a la particularité de faire partie des voies aériennes, donc l'étude pour la respiration, les voies aériennes ici pour la mastication et l'adhésion. Une zone qui est importante pour la communication. Et la troisième zone, c'est une zone qui est là, aussi par le drainage lymphatique important.

(0:49 - 1:02)

On va voir, ressortir dans la pathologie, il y a aussi dans la clinique pour le traitement. Il y a les centres cliniques souvent, les centres cliniques doivent être présents. Les centres cliniques doivent insister aussi toujours sur la recherche d'une voie sympathétique.

(1:03 - 1:20)

Et le traitement, qu'il soit chirurgical ou par radiothérapeutique, doit prendre en considération le risque de tractation polyvalente. Donc le concert de la Nantes, c'est le présent des concerts de la capitale du Cap. C'est quand on situe 9% des concerts de la voie aérienne.

(1:22 - 1:36)

Il faut faire la part entre le concert de la Nantes mobile, et le concert de la base de Nantes. Ici, on va voir les deux, puisqu'on va traiter la Nantes. Nous savons pourquoi on fait la part entre les deux, parce que le concert de la Nantes mobile, c'est parti du Cap.

(1:36 - 1:49)

Celui de la base de Nantes, c'est parti de l'oropharynx. Deux régions anatomiques qui sont différentes, surtout en anatomie, surtout en diagnostic, surtout en thérapeutique. Ils n'ont pas le même pronostic.

(1:51 - 2:07)

Le traitement, ça va associer la radiothérologie, la radiothérapie, la radiothérapie, la radiothérologie, la radiothérologie. C'est important pour accomplir le concert du Cap. Et le pronostic, il reste réservé, surtout pour les concerts de la base de Nantes, vu le siège postérieur.

(2:09 - 2:32)

En général, le thérapeutique, elle est tactique, et l'accès chirurgical, elle est moins facile par rapport à la Nantes mobile. Alors, anatomiquement, la Nantes, c'est un anglais musculaire. Donc, on a deux parties, une Nantes mobile, une base de Nantes, séparée par ce qu'on appelle le Vélangois.

(2:33 - 3:08)

Il est fondamental, le Vélangois. C'est quoi, en fait, le Vélangois ? Est-ce que c'est un cyan ? Ce n'est pas un cyan, c'est les papilles gustatives, d'accord ? Les papilles gustatives qui siègent à la partie postérieure de la Nantes mobile, les formes d'un V. Donc, lorsqu'on les examine, on voit une attraction, une forme de longueur, avec un centre. Il y a certaines patients qui consultent juste parce qu'ils ont vu ces modules, ils sont dérangés parce que c'est ça qu'on n'allait pas comprendre.

(3:08 - 3:33)

Ils ont l'impression que c'est anormale, c'est pathologique. Il faut savoir en connaître, parce que vous rendez, parce que vous faites une contraction. D'abord, vu que vous regardez votre langue, votre langue de mémoire, vous allez voir le Vélangois, quand il vient d'essayer, qui est marqué, à la limite, en arrière de la langue mondiale, en arrière, c'est la place de langue la plus présente, d'organes influides.

(3:34 - 4:19)

Plus on se dirige en arrière, plus il y a d'organes influides, et plus c'est une zone qui est inconnue. Donc, la langue mondiale comprend deux bords vaginaux, le bord vaginal droit et gauche, vous avez la pointe de l'avant, vous avez un sillon médian, vous avez une face dorsale, et en bas, une face dorsale qui est épaisse, et en dessous, vous avez une face qui est lisse, transparente, c'est un peu une face d'entraine. Bon, ça dépend si tu as 17 muscles, et le drainage lymphatique, il se fait au niveau des chaînes cervicales.

(4:20 - 4:58)

Là, c'est différent, c'est un petit peu différent par rapport au larynx et au cavon, pourquoi ? Parce que le drainage lymphatique il se fait au niveau de la chaîne du myocarde, 2, 3, 4, mais il se fait aussi au niveau du montonnier et du maxillaire. Bon, on va voir la participation de l'environnement sous-montonnier et sous-maxillaire. Donc, l'alarme se draine au niveau sous-montonnier, sous-maxillaire et au niveau de la chaîne du myocarde, du myocarde supérieur, moyen et inférieur.

(4:59 - 5:29)

Alors, quelles sont les particularités de ce drainage lymphatique ? Est-ce qu'il est croisé ? Est-ce qu'il est bilatéral ? Oui, il est croisé, il est bilatéral, mais au niveau de deux régions. Au niveau de la pointe et du sillon médian, donc au niveau de la pointe du sillon médian, le drainage lymphatique il est croisé, il se fait de façon bilatérale. Là, je vous le montre bien.

(5:30 - 5:57)

Et au niveau de la base de l'ambre, au niveau de la base de l'ambre ici, le drainage lymphatique il se fait de façon bilatérale. Par contre, au niveau des corps marginaux, sur la surface latérale ici, les corps marginaux et le sillon médian, il se fait du côté au haut latéral. C'est une notion très importante, qui va nous guider dans l'application du curage ovulaire de la zone lymphadélectromique et de l'infraction chirurgicale.

(5:57 - 6:25)

C'est-à-dire savoir quelles sont les membranes, qu'est-ce qu'on va repérer d'un côté, d'un autre côté, etc. Bon, allez, c'est un schéma qui montre ce lieu qu'on a vu tout à l'heure, ça c'est une ville postérieure, on a couvert le pharynx de haut en bas, rhinopharynx, oropharynx et hypopharynx. Donc, ça c'est le rhinopharynx qu'on vient de voir avec l'infestation anémique ici et le thorax qui est roseux.

(6:26 - 6:55)

Là vous avez le voie du thorac qui marque l'anémie entre le rhinopharynx et l'oropharynx. Et puis vous avez le larynx ici, avec l'épiglotte. Donc, le tube laryngé, juste derrière, en bas, vous avez deux épines, ça c'est quatre bouches de deux épines.

Et latéralement, c'est des sévices féminins. Il y a du gouttière, pharyngo, laryngé. Gouttière, pharyngo, laryngé.

(6:55 - 7:06)

Alors, ce qui nous intéresse ici maintenant, c'est l'oropharynx. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de parler de la langue et de la base de langue. La base de langue, comme on l'a dit, fait partie de l'oropharynx.

(7:06 - 7:16)

Alors, vous voyez ici l'oropharynx. Au centre, il y a la langue, avec le veine et le voile ici en devant, et les organes d'influx. Ça, c'est la base de langue.

(7:17 - 8:53)

L'oropharynx, marqué par le voile qui est parlé par le haut, la région américaine, latéralement, en bas, vous avez l'épiglotte, la partie plus supérieure de l'épiglotte, avec ce qu'on appelle les

malécules. Vous connaissez les malécules ? C'est cette impression entre cette impression ici, la dépression, à ce niveau-là, qui est entre l'épiglotte et la base de langue, ce qu'on appelle les malécules, bien sillon de l'osso épiglottique. Vous voyez les foncettes ? L'osso épiglottique, ce qu'on appelle au minimum les malécules.

Donc les malécules sont en partie de l'oropharynx. Donc ça, c'est concernant l'anatomie de la base de langue. Donc vous voyez que, vous savez déjà que une bonne partie des muscles de la langue s'insère au niveau de l'osso épiglottique et au niveau de la mandibule.

Donc, c'est les muscles de la langue. A l'intérieur de la langue, il n'y a pas d'os, il n'y a pas de cartilage. Il y a, au minimum, des tissus musculaires, des artères, qu'on appelle les artères linguales, c'est des manches de la langue qui vascularisent la langue, et qu'il y a des nerfs.

Quel nerf vascularise la langue ? C'est le nerf de 12, c'est le ventre hypoglossal. On a un nerf de chaque côté. Alors, le fait d'avoir uniquement des tissus musculaires, c'est que l'extension du moral, il n'y a pas vraiment de barrière.

(8:55 - 9:10)

Alors, votre motivateur, il peut facilement toucher la face dorsale de la langue, il peut facilement s'étendre jusqu'au niveau du plancher. Il n'y a pas de barrière. Il y a un septième médian qui n'est pas très résistant, il y a un septième qui est incomplet.

(9:11 - 10:09)

Pourquoi ? Ce n'est pas vraiment une barrière à l'extension du moral. De ce fait, il y a des éléments qui rendent ce qu'on sert d'une langue qui est longuement prononcée, c'est qu'il n'y a pas vraiment de barrière, facilement, d'extension du moral, parfois infraclinique. C'est-à-dire que les chirurgiens ont l'impression de la langue, ils ont l'impression qu'il a enlevé toute la tumeur, mais peut-être qu'il y a des extensions microscopiques qui se font à travers les fibres musculaires et qui vont expliquer pourquoi le pourcentage de mesurer dans le conservateur de la langue est élevé.

Alors, c'est que il n'y a pas vraiment de limite nette de la tumeur, parce que la tumeur peut s'étendre facilement, on voit ici, le long des fibres musculaires. On a ces parmi les éléments qui rendent ce qu'on sert méchant. Surtout lorsqu'on met dedans une tumeur infiltrante.

(10:11 - 11:11)

Alors, on parle d'épuis de drainage lymphatique, on a l'épuis des croisés au niveau de la pointe de la ligne médiane de la base du ventre, on voit ici la classification d'orbites forcément désert-ventrionnaire, le groupe 1, c'est le groupe saumontal et subventileur, le gypélocarotidien supérieur, moyen, inférieur, et la chaîne spinal et susflaviculaire, on a. Alors, maintenant, on va

voir deux formes qui vont voir le cancer de la langue mobile, après, on parlera, il y en a un qui monte sur le cancer de la base de langue. Le cancer de la langue mobile, donc c'est une fréquence qui est relative en France, en général, c'est des lignes de vocabulaire, c'est quand même élevé, et c'est à peu près 30% chez eux, par saison de pandémie, du cas. L'âge moyen, c'est vers les cinquantaines, mais on a vu des cas, je ne parlerai pas trop bien d'encore, mais un jeune de 24 ans envahit un jeune de 18 ans qui a vraiment un cancer avéré de la langue.

(11:13 - 11:57)

Donc, c'est vrai qu'actuellement, il y a une certaine modification de l'épidémiologie du cancer concernant l'âge d'apparition du cancer, on n'est plus devant des personnes qui, à partir de 60 ans, on les voit, donc, chez les sujets jeunes. Mais les âges extrêmes, trans 70 ans, avec une prédominance masculine, pourquoi ? Parce que, dans les facteurs de risque, il y a le tabac, on dit tabac, on dit que c'est masculin, l'alcool, c'est un bon facteur qui augmente encore le risque. Le nom pour les états glucodendaires, c'est la présence de chimodendaires, caridendaires, donc, les cassettes à caries, qui va périder tout le temps le borborex natal.

(11:58 - 12:13)

Ça va, à la langue, entraîner l'apparition de lésions précancéreuses. Lésions précancéreuses, c'est ça. C'est ce qu'on appelle soit des leukoplasies, c'est des lésions blanchardes, ou bien des érythroplasies.

(12:14 - 14:23)

Si vous voyez ces lésions chez des personnes, des lésions blanches comme ça, ce sont des lésions précancéreuses, qui nécessitent une vérification histologique obligatoire. Pour vérifier si le patient n'est pas arrivé à un stade de carcinome in situ, ou bien même un carcinome invasif. Un facteur viral, l'HPV, le human papillomavirus, qui entraîne la papillomatose laryngée, dont on a parlé au début d'un axe, elle est incriminée dans le concept de la maladie.

C'est surtout au niveau de la base de l'âme. Certains sérotypes, c'est-à-dire que le 16 et le 12, pas tous les HPV, mais certains sérotypes sont incriminés dans la génèse. C'est tout ce concept.

Le facteur génétique, il y a un certain facteur génétique, mais dont le rôle n'est pas très important. Les lésions précancéreuses, c'est ce qu'on vient de voir. C'est des leukoplasies, des érythroplasies.

Et lorsqu'on fait des prélèvements avec une physiologie, soit on est devant une dysplasie légère, toujours on fait des opérations sévères, soit on est devant une dysplasie légère, soit modérée, soit vraiment une dysplasie sévère. Lorsqu'on dit le patient a atteint le stade de dysplasie sévère, c'est l'équivalent d'un carcinome, etc. D'accord ? Ça nécessite un traitement chirurgical et une

surveillance.

C'est vrai, le traitement chirurgical ne va pas être agressif, on va juste enlever la bouche superficielle de la muqueuse, d'accord ? Avant de faire ce qu'on appelle une mycoséctomie, mais il faudra surveiller le patient pour voir, pour guetter l'apparition d'une récurrence. Lorsque l'on dit les moments généraux, c'est quand ce sont les lésions précancéreuses, c'est des lésions qui vont être soit bourgeoises, soit plus éveillées, soit infirantes, ou bien mixtes, c'est-à-dire qu'une soit bourgeoise, une soit infirante, d'accord ? Plus la tumeur est infirante, plus elle est infirante. L'infirance, c'est-à-dire qu'elle va infiltrer, elle a une facilité d'infiltration profonde, surtout au niveau de cet organe, parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas de barrière.

(14:24 - 14:45)

Vous voyez la tumeur, vous l'apparpez, vous avez l'impression qu'il est au niveau d'un organe mobile, mais intra-génériquement, il a déjà atteint le V1. Et vous n'allez voir cette expansion que sur l'hémagénite, qui est éventuellement liée à la tumeur. Alors, la microscopie montre que dans plus de 90% des cas, c'est un carcinome épidermoïde.

(14:46 - 15:02)

Épidermoïde, c'est le sujet très proche au niveau des doigts aériens. Il y en a aussi supérieurs, sauf pour le rhinovirus. On peut avoir d'autres cancers comme les autres, certains même, mais ça reste beaucoup plus rare que le carcinome épidermoïde.

(15:05 - 15:28)

Retenez cet aspect-là, lorsque vous voyez ce genre de lésions, ça c'est très probablement un cancer. Lorsque vous allez faire l'examen clinique, on va le voir, il y a certains signes qui vont nous orienter vers un cancer, et d'autres signes qui peuvent nous orienter vers autre chose, parce qu'il y a des déconstructions qui peuvent donner cet aspect microscopique à l'inspection. À l'infection, c'est différent.

(15:30 - 15:47)

Alors, l'extension, comme je l'ai dit, il n'y a pas de barrière. On peut avoir l'extension locale pour les déconstructions, vers la base de longue ou vers l'arrière. Latéralement, on peut avoir une extension au niveau de l'argent, en italien, pilier antérieur, l'amital, pilier postérieur, etc.

(15:48 - 16:17)

Par exemple, il y en a un qui peut être homolatéral, ou bien bilatéral, si il touche le coin de la main, ou bien natalipédial. Des métastases qui sont moins fréquentes que par rapport au carcinome indifférenciées, surtout au niveau des poumons. Alors, comment ça va se manifester cliniquement ? Après l'apparition de la lésion au niveau de la langue, soit des lussurations, il y a

vraiment de la tumeur.

(16:17 - 16:47)

Le patient va voir sa lésion, il va l'attraper, il va avoir un gêne à la situation, c'est-à-dire du corps congelé, du goût de menthe, parfois des crachats, saignement. Si la tumeur est vite profonde des membres, ça va même entraîner des otalgies réflexes. C'est comme pour le carcinome du larynx, si la tumeur est située au niveau des vagues systélotiques, parce qu'il a touché le bord marginal, ça va donner en effet des otalgies homolatérales à la lésion, et l'autoscopie va être normale.

(16:48 - 17:06)

Les membres, toujours devant les otalgies réflexes, sont patientés pour ensuite. Et là, les douleurs vaguent, vous faites l'autoscopie, il n'y a rien, il ne faut pas dire qu'il n'y a rien. Vous le dites, votre oreille, elle est normale, on voit, pourquoi posez-vous un changement ? On commence à examiner.

(17:07 - 17:36)

Dans l'otalgie réflexe, on commence par l'examen de l'articulation temporopendiculaire qui peut entraîner des otalgies réflexes, des caries dentaires, prosthétiques, surtout au niveau des sagesse ou bien des molaires, au niveau des abdominales, un traitement à l'italien ou à l'ancien italien, ou bien une tumeur. Tumeur de la langue, tumeur d'un sonde, tumeur de l'amygdale, tumeur de la bronchie du cache, tumeur de la plaque, tumeur de l'hypopharynx. Tout ça, c'est des cancers qui peuvent donner des otalgies réflexes.

(17:36 - 18:59)

On ne peut pas s'arrêter à l'autoscopie et dire que ça ne marche rien. L'adénopathie cervicale, ça se trouve au niveau sous-maxillaire, sous-mental, qui est dure, qui est fixée, qui est progressive, qui est constante, qui n'est pas toujours douloureuse, elle est un peu sensible, c'est au contraire par rapport aux adénopathies qui sont d'origine dentaire. Et lorsque vous allez passer après l'interrogatoire et les signes d'appel en recherchant les facteurs de risque sur le patient établi, qu'est-ce qu'il y a d'alcoolique, qu'est-ce qu'il y a d'alimentaire qui est associé, vous allez voir des lésions.

Alors la lésion à l'inspection est irrégulière, vous voyez, ce n'est pas la muqueuse lisse de la cavité buccale de la langue, mais c'est une zone qui devient irrégulière avec des bourgeons par endroits et au centre, il y a de l'écaille et de l'ulcération qui est associée, et c'est des bords qui sont irréguliers, mais le plus important ici c'est la palpation. Vous mettez un gant, vous mettez deux gants et vous palpez la lésion, demandant au patient de faire la protrusion de la langue et on commence à palper la langue. Un, on demande au patient de faire la protrusion, vous voyez,

puisque la langue est toujours mobile.

(19:01 - 19:21)

Il y a des cas où le spatule est très infiltrant, surtout en profondeur, le patient n'arrive pas à faire la protraction, la langue est fixée. Il n'arrive plus à faire la protraction, pourquoi ? Parce que les muscles de la langue ici, ils sont infiltrés. Donc s'il fait la protraction, il devient impossible.

(19:23 - 19:38)

S'il fait la protraction, ça veut dire que c'est un élément qui est, on va dire, pas de monde forensique, mais c'est un bon élément qui nous dit qu'il y a encore de la chance peut-être de pouvoir faire de la chirurgie. Un peu. Bon, protraction et je palpe.

(19:38 - 20:11)

Je palpe la lésion. Alors, pour faire la palpation, par exemple, une infection, un syphilis, une tuberculose, et un cancer, c'est l'induration. C'est une lésion ulcérée, bourgeonnante, qui est indurée, qui est dure.

C'est-à-dire que je palpe la lésion, elle est dure sur les verges, elle est dure au centre, et elle est dure même en profondeur. Parce que la lésion n'est pas limitée ici. Elle est déjà infiltrante en profondeur.

(20:11 - 20:22)

Quand on a une infection, par exemple, une tuberculose, la lésion est lisse. Il n'y a pas d'induration en profondeur. C'est un élément qui est très important et qui concerne fortement la lésion maligne.

(20:23 - 20:35)

Donc, la palpation, il apprécie l'infiltration et les caractères de la base, l'infiltration. L'infiltration, il est indurée du bord marginal avec des bords qui sont surélevés. C'est le bourgeonnement qui est associé.

(20:35 - 20:51)

Donc, l'induration, très importante, et l'induration, elle est appréciée à la palpation par l'inspection. C'est regarder et palper. Et en même temps, voici des exemples de lésions.

(20:51 - 21:02)

Vous voyez ici la grande ulcération qui représente une patiente. Ce bourgeonnement, c'est irrégulier. Ce bourgeonnement, vous l'avez vu avec une ulcération au centre.

(21:04 - 21:21)

Ça ne veut pas dire que c'est malin, mais lorsque je vois, c'est dur. Il y a une infiltration en profondeur ça veut dire que c'est régressif. Donc, en mettant là les dons, on parle de la lésion.

(21:21 - 21:47)

On examine la lésion et il faut apprécier une chose qui est capitale, c'est l'extension par rapport à la ligne médiane. À ce niveau-là, il faut voir est-ce que la lésion en profondeur, est-ce qu'elle atteint ou est-ce qu'elle franchit la ligne médiane. Pour que la lésion ait franchi la ligne médiane, ça veut dire que si je propose un traitement chirurgical pour les herbes endogymènes, il doit être bilatéral.

(21:47 - 22:16)

Parce que cette zone-là, médiale de la langue, il atteindrait un principe qui est croisé. Il se fait des deux côtés. Tout ça, c'est apprécié à la palpation et à l'inspection en vérifiant le reste de la muqueuse du cas comment il est, est-ce qu'il y a une lésion qui est associée face à un terme de la jour, examiner au niveau de la face le ventral de la langue, palper l'agent cis, regarder l'agent cis d'un coin, le corps des lièvres et palper aussi la base de langue.

(22:17 - 22:38)

En tirant sur la langue, je peux palper la base de langue pour voir est-ce qu'il y a une extension vers la base de langue de la lésion. La lésion, je ne l'ai pas, elle est dure. Je vérifie sur l'extension vers la ligne médiane, est-ce qu'elle passe sous la fin de la ligne médiane, est-ce qu'elle s'étend vers la branche articale, est-ce qu'elle s'étend vers la base de langue.

(22:38 - 23:42)

Des éléments qui sont très importants à noter. Après, on passe à l'examen de la région cervicale, il faudra voir est-ce qu'on a des adénopathies au niveau des herbes, sous le mentonnier, sous le maxillaire, la chaîne du culo-carotidien, membres d'adénopathies qui sont unilatérales, bilatérales, leur siège etc. et compléter par l'examen ORL pour rechercher une localisation concomitante.

Si le patient a une dysfonie, pour faire une expérience pour voir est-ce qu'elle a une tumeur au niveau du naraxe etc. et rechercher des signes d'arrêt de métastase ponceuse, osteoarticulaire, pulmonaire etc. Alors, les diagnostics qui différencient, comme on l'a dit, il se fait avec des lésions traumatiques, les tumeurs mélides, les papillons, les fibrandes, on peut avoir même des urinaires, on vient des graines de l'homatose, donc tumeurs gluoses, séchimistes.

(23:43 - 24:54)

Alors, là-bas, la différence c'est quoi ? Lorsqu'il sent une sération d'origine traumatique, normalement, elle doit disparaître rapidement. Le morceau de la langue, ça donne parfois une lésion qui ressemble à une tumeur, c'est la séance, le contexte est très beau, le patient peut dire qu'il a eu une morceau, mais ce truc, il faut la suivre, normalement ça peut cicatriser rapidement. Même par façon de traitement, ça va cicatriser rapidement et facilement, on aura une muqueuse saine.

Dans les tumeurs mélides, comme je l'ai dit, pour le rhinopharynx, la différence entre tumeur maligne, tumeur mélide, au niveau des brosses nasales, au niveau des brosses aériennes, c'est la muqueuse qui est beaucoup pour la tumeur, et les saines. Alors, si vous avez un urinant ou une fibrande de la langue, c'est une information gentille qui est sur la muqueuse et qui respecte la muqueuse, c'est-à-dire la muqueuse qui est beaucoup pour la lésion, c'est juste la tumeur faction, mais elle est saine et elle est lisse, il n'y a pas d'éléments congelants, même si vous êtes au bout d'un mille par an. Les granulomatoses, la tuberculose et la syphilis sont des injections, mais dans ce cas-là, la muqueuse est atteinte des amputations congelantes.

(24:55 - 25:21)

C'est une serrée. Et la différence, c'est qu'à la fin de la séance, il n'y a pas d'enduration. Pourquoi ? Il n'y a pas d'enduration et les morts ne sont pas vraiment surélevées.

On n'avait pas le concept des morts. Et surtout, il n'y a pas d'infiltration, il n'y a pas d'enduration en profondeur. Mais ça n'empêche que, même devant ces examens-là, il faut faire des prélèvements, parce que parfois on va avoir une association des deux.

(25:23 - 26:19)

Alors, d'où le réflexe qu'il faut toujours garder devant toutes les personnes évoluant plus de 15 jours au niveau de la langue, conditions congelantes, et suspect jusqu'à preuve de contraire. Plus de semaines de lésions congelantes, plus de serrées. En tout cas, il faudra faire une biopsie et ne pas lâcher le patient dans la nature.

Donc, une fois qu'on a fait notre examen, on est sur les ondes du patient, qu'est-ce qu'il a comme facteur de risque, à quoi est-ce qu'il est cardiaque, qu'est-ce qu'il a de l'adrénal, qu'est-ce qu'il a de l'hépatite, etc. On a été sur la tumeur, sa présence, on a fait une étude clinique de la lésion, son extension, est-ce qu'il y a des associations bioniques qui sont associées. Après, il faudra faire, on a fait une biopsie pour confirmer le diagnostic, après il faudra faire ce qu'on appelle une palendoscopie.

(26:19 - 27:29)

Pourquoi une palendoscopie ? Parce que c'est le même facteur de risque, c'est toujours le tabac et la douleur, donc on peut avoir un concert au niveau de la pharynx, des couffes à pharynx, de

l'œsophage, donc on fait une palendoscopie sous anesthésie générale en examinant les sinuscérifores, la couche de l'œsophage, le larynx, et on en profite pour faire une bonne palpation de la base de l'onde, parce que la base de l'onde on s'examine surtout sous anesthésie générale parce qu'elle est relâchée, on introduit le doigt et on fait le tour de la base de l'onde jusqu'au niveau de l'océan pour voir ce qu'il y a de la durée qui s'étend en conservant. Alors, concernant l'imagerie, concernant l'imagerie, l'examen de Schwarzschild IRM pour ce qu'on met devant, alors, qu'est-ce que font deux parties molles, trois doses, d'accord ? Donc on suspecte maintenant d'une expansion grosseuse, notamment au début, mais au niveau de l'océan, dans ce cas-là, on fera un scalette. L'IRM permet d'apprécier l'infiltration musculaire, mais surtout, rechercher une atteinte au niveau de la librairie.

(27:31 - 29:51)

C'est un élément qui est très important, remarquez ici, vous avez une lésion, une IRM co-praxiale au niveau de la lampe, ça c'est l'intérieur, l'intérieur, l'extérieur, le droit et le gauche, et vous avez ici un hyper-signal du corps marginal gauche qui s'étend vers la pointe, donc ça n'envahit pas complètement la pointe, mais ça commence à infiltrer la pointe, mais remarquez que l'IRM ici, elle reste intacte. Contraire ici, ça c'est un scalette, c'est un scalette qui montre la lésion et qu'il y a déjà atteint l'IRM. Donc, le pronostic ici n'est pas le même qu'ici, le traitement n'est pas le même, il est différent, c'est vrai que il peut être chirurgical, mais là il faudra enlever toute la partie mobile de la lampe, et ici on peut faire uniquement une élite brosectomie.

Donc l'hématurie est importante pour apprécier l'infiltration profondeur de l'IRM, l'infiltration profondeur vers la base de lampe, vous voyez ici que ça touche la base de lampe, ça c'est une lampe, ça c'est la base de lampe qui est déjà touchée de cette partie là, hop et le scalette permet de voir éventuellement si on a une extension au niveau de la lampe au début, parce que la lésion ne touche que le point physical et qu'elle s'étend vers la lampe au début. Le bilan d'extension va comporter surtout un scalette thoracique, cervicale et thoracique systématique pour rechercher des menaces anglionaires, de leurs membres, unilatéral, unilatéral, alors unilatéral c'est ce qu'une lampe sous forme de l'enducue monaire, ou par exemple parfois sous forme de pleuritis ou d'efforchement, une panoramique d'envers, pourquoi ? Après il faudra faire une panoramique d'envers, une radio-panoramique d'envers, pas exactement pour l'extension, c'est le scalette qui va donner plus de détails, mais surtout pour apprécier l'état d'envers. Une panoramique d'envers nous montre si on a des caries d'envers profondes qui vont nécessiter des extractions d'envers, parce que ces patients-là ils sont exposés à la radiothérapie.

(29:52 - 30:16)

Par exemple, il y a des maladies thérapeutiques qu'on va mettre en introduction, c'est la radiothérapie. La radiothérapie s'est faite sur la cavité buccale et que vous avez des caries d'envers au niveau par exemple de l'arcade inférieure, ça expose le patient à de l'ostéoradionécrose, qui est un traitement très difficile. Le traitement est surtout préventif.

(30:17 - 30:41)

On recherche uniquement les caries d'envers, on voit leur importance sur la radio panoramique, il faudra enlever les dents pour bien les traiter avant de proposer au patient une radiothérapie. Sinon, si on a une ostéoradionécrose, c'est une catastrophe. L'endographie hépatique recherche des métastases au niveau abdominal.

(30:42 - 31:04)

Et l'examen clinique ainsi que l'examen général recherchent une tabasse, c'est tout le bilan biologique. On cherche les analytes endostases, on recherche, même si ce n'est pas possible, une insulose panachronique, etc., une anémie qu'il faudra éventuellement corriger. Alors, à la fin, on peut sanifier le patient.

(31:05 - 31:30)

Lorsque la tumeur est inférieure à 1 cm, c'est un B1, avec moins de 5 mm d'invasion profondeur. L'invasion profondeur, c'est à la clinique et c'est autour de l'IRL. Même si la tumeur, par exemple, est de 1 cm, mais avec une infiltration profonde, en profondeur qui est importante, par exemple pour cela, d'un 10 mm, on n'est plus en T1, on est déjà en T2.

(31:31 - 31:57)

T2, c'est inférieur à 2 cm, mais avec une infiltration qui dépasse 16 mm, et moins de 10, T3, pour cette tumeur, ne dépasse qu'un centimètre, ou bien plus d'un centimètre d'invasion profondeur. Dans les T4, c'est surtout la teinte osseuse, ou bien la teinte au niveau des espaces profonds. On concentre sur l'espace intemporal, l'espace plastiquateur, ou bien la base du crâne.

(31:57 - 32:22)

Donc ça, ça nous permet de classer le patient. Mais gardez surtout cette idée sur la classification de la tumeur, c'est en fonction de la taille de la tumeur et de l'infiltration profondeur. La teinte d'ombilinaire, dans les N1, c'est une teinte homolatérale unique, ou bien unique qui sent inférieur à 6 cm.

(32:23 - 32:38)

Pour ce qui sent contre-latérale et toujours inférieur à 6 cm, c'est le N2. Lorsqu'elle dépasse 6 cm en général, c'est un N3. En sachant que la teinte d'ombilinaire, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est un facteur très important.

(32:39 - 33:48)

Un patient qui est classé, par exemple, T3, sommet d'assasse d'ombilionnaire, comparé à un

patient qui est lui aussi T3, mais avec les mêmes avant-ombilionnaires, le facteur d'assasse qui est plus mauvais que le patient qui a le sommet d'assasse d'ombilionnaire. Alors, le traitement, il repose sur la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. La chirurgie consiste à faire l'exérèse de la tumeur.

Le geste qu'on peut faire, ce soit une hémiglossectomie, c'est-à-dire chaque fois qu'on a une tumeur qui ne dépasse pas l'énigme médiane, sans extension à la base de l'homme, on répète un procédé d'abattre par l'hémiglossectomie. Lorsque la tumeur dépasse l'énigme médiane, dans ce cas-là, il faudra faire une hémiglossectomie transverse, on peut juste enlever presque tout à l'homme morbide. Alors, la reconstruction qu'on peut la faire, grâce à des lombos, soit c'est des lombos qu'on va ramener par la région cervicale, ce sont des lombos musculo-brutalés qu'on peut ramener et faire introduire dans le bras pour reconstruire le patient morbide.

(33:48 - 34:21)

Combien de fois on peut amener des lombos pelliculés, c'est-à-dire du cran à l'ostomose. Par exemple, on peut enlever un lombo au niveau de l'avant-bras, avec son pellicule vasculaire, qu'on va ramener et brancher par exemple sur le parterre et la même voile. Il y a une de ces branches, sur le parterre et la même voile, qui va permettre la vascularisation du lombo pour donner du volume à la langue et avoir moins d'authenticité sur le plan fonctionnel.

(34:21 - 34:49)

La chirurgie est complétée toujours par un curage bombolionnaire qui doit être unique ou bilatéral. Et lorsque le curage est fait, il doit toujours comprendre le niveau de son mentonnier, son maxillaire et les juges de carotidien. Il doit être soit homolatéral, lorsque la lésion est latéralisée par le ventral trigal, chaque fois que ça touche la pointe ou bien à l'immédiat, quand c'est vrai, il faut le faire comme ça, bilatéral.

(34:49 - 35:54)

Et là, ça nous fait un geste quand même qui est nouveau. Parce qu'on dit par exemple un curage bombolionnaire, c'est pas tout de suite possible. Pour le patient, pour le chirurgien qui a la médecine des personnes, en général ça ne pose pas de problème, sauf lorsque on a des complications infiltrantes localement.

Mais pour le patient, il y a des complications qu'il peut avoir. On va enlever et disséquer tout l'axe du myeloma musculaire, on va disséquer le nerf, on va disséquer le plexus cervical profond, donc le risque d'avoir des hypoesthésies au niveau de la région ombiculaire, des douleurs au niveau de l'épaule, c'est-à-dire sur le ventral, on risque d'avoir de la lymphorée, alors parfois on a des ouvertures susceptibles au niveau de la partie gauche où il y a le canal thoracique. Vous connaissez le canal thoracique ? Le canal thoracique en bas, parfois il est touché au cours du cuirage, on risque d'avoir une lymphorée qui va nécessiter un traitement, ou bien parfois un

motrice chirurgical.

(35:54 - 36:12)

Donc c'est par quel bout. Parfois on peut avoir, en complication du cuirage longuier, en complication du cuirage longuier, on a un spinal. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans le spinal, ce n'est pas fonctionnel, quel est son rôle ? Sur les patients de l'épaule.

(36:12 - 36:29)

Très bien. Donc le patient, après, la chirurgie, il peut venir juste de l'épaule. Pourquoi ? Parce que, soit de façon volontaire, le chirurgien, il a réservé le spinal parce que la délompatie était adhérente dans le spinal, ou bien activement, il peut se toucher.

(36:30 - 36:56)

Il y a plein d'éléments qu'il faudra distinguer, il y a le spinal, l'os, le petit cercle profond, la ventricule interterre, il faut respecter l'élément de l'os, il faut respecter la percarotide, il y a plein d'éléments qu'il faut respecter. Ce n'est pas un geste qui est facile, c'est pour ce qui est fait de façon bilatérale. Ça prend du temps, mais pour le patient, il y a quand même des risques qu'il faudra expliquer et essayer d'éviter pour la chirurgie.

(36:57 - 37:32)

La chirurgie thérapeutique, c'est un type de radiothérapie. D'accord ? Ce sont des arcs métalliques qui sont radioactifs qu'on va mettre au niveau de la tumeur, au niveau d'alarmes, localement, qui sont irradiants mais qui vont donner une irradiation quantitative. C'est pas comme la radiothérapie externe où le patient doit venir cinq fois par semaine pour recevoir sa séance et repartir.

(37:32 - 38:42)

Là, on met les arcs métalliques qui sont radioactifs, le patient les garde chez lui, bien sûr, il doit être isolé, tout ça. Bon, c'est efficace, mais pour les tout petits tumeurs, il y en a un qui sont de petit taille. C'est l'indication, il est très très limité.

C'est rarement qu'on a des patients qui sont bien consignés aux tumeurs par exemple, de 5 millimètres, etc. Mais c'est surtout la radiothérapie externe soit qui va être utilisée d'emblée si le patient n'est pas opéré associé à la chimiothérapie, mais à chaque fois que la chirurgie peut être faite, on préfère de faire la chirurgie en quotidien. Bon, au niveau de la tumeur, on fait le curage bombolionnaire et en fonction des résultats qu'on a, on va associer la radiothérapie à la chimiothérapie, ou bien la radiothérapie seule, ou bien parfois on peut se contenter de la chirurgie, de voir des petits tumeurs par exemple de 2 centimètres où on a fait l'exercice complète avec des manches saines vérifiées à l'examen anatomique pathologique pour cet

opérateur.

(38:44 - 39:05)

Voilà, donc ça c'est concernant le cancer de la langue mauvaise, c'est-à-dire en avant du venin d'oie avec les deux iméranges et la pointe. D'accord, maintenant on verra l'autre forme clinique qui est le cancer de la base de langue. Heureusement, elle est moins fréquente que la première.

(39:06 - 44:43)

Elle appartient à l'oropharynx donc c'est une zone qui est une infophile plus le metastase bombolionnaire plus profonde plus le rapport norme plus importante que la langue mobile concernant la fonction c'est-à-dire que je veux enlever la langue mobile, le patient qui est là va être gêné sur le plan de la communication si je mets un mot et que ça marche, le patient va être santé mieux par contre, je ne pourrai pas aller enlever la base de langue de mon chirurgicale fonctionnellement, c'est pas concordant avec les fonctions de l'exécution et de respiration correctes et de ce fait, ce sont des cancers qui sont communes ou pas les facteurs de risque sont les mêmes que la langue donc, le lamyx c'est une phase synoptique avec l'alcool mais en plus, on a le HPV 0,7 et 0,8 qui nous donne plus de carcinements chez le sujet jeune donc si vous voyez un cancer un carcinome surtout un carcinome vulnérable de nos langues concernant le sujet jeune il faut penser surtout au facteur viral donc la situation profonde fait que le diagnostic souvent est tardif, parce qu'une zone qui est profonde n'est pas très gênée, il ne voit pas sa lésion et les tumeurs à ce niveau là sont infiltrantes, donc toujours il n'y a pas de barrière il s'égale vers l'isologique ce qui fait qu'il est infiltrant, il est radio résistant et en plus il est très infusible, donc pourquoi parce que tout l'oropharynx comme le rhinopharynx, il a un drainage lymphatique qui est très important, donc plus on recule au niveau des cavités mucanées vers l'oropharynx, plus on remonte vers le rhombus, on a un drainage lymphatique qui est très important et de ce fait, on aura des manifestations d'angulionnaires plus fréquentes alors sur le plan clinique si j'ai dit, soit une autalgie réflexe, soit une audiénophagie, ça veut dire une bénédiction douloureuse pourquoi, parce que les aliments s'accrochent à la tumeur et ça fait mal l'examen d'inspection avec un miroir arrangé, ou bien avec une nasophibroscope qui va nous montrer la lésion que je montre plus sereinement mais toujours, toujours garder ce réflexe là lésion de la base de langue égale inspection de la palpation même au niveau de la base de langue, il faut essayer de tirer sur la langue quand elle est trop presse et avec l'autre main, on essaie de palper une fois qu'on a un caractère enduré les entiers durs ça y est, ça va très probablement c'est un cancer, surtout devant, bien sûr, une lésion bourgeoise pas une lésion avec une muqueuse disse, ça c'est autre chose donc lésion endurée à la base de l'instauration avec un signé contact et apprécier l'expansion latéralement vers la région italienne, en avant vers le plancher du cas et vers l'endroit mobile on complétera par la nasophibroscope pour voir l'expansion vers l'endroit max et par l'examen des herbes d'angulionnaires, rechercher des métastases d'angulionnaires qui sont très fréquentes progénit parce que c'est très lymphophile rechercher des signes d'appel de métastase à distance et apprécier l'état général comme le reste

des cancers alors concernant le traitement les traitements et surtout c'est la chirurgie j'ai mis ici en premier chirurgie, mais c'est rare qu'on propose la chirurgie, pourquoi ? la chirurgie on peut la faire si on peut enlever juste une partie de la base de l'orgue, des membres de petits tumeurs par exemple de 1 voire jusqu'à 15 mm lorsque la tumeur dépasse 2 cm l'exercice devient difficile parce que vous savez qu'en cancérologie on n'enlève pas uniquement la tumeur lorsqu'on l'opère on enlève la tumeur avec des marges saines, faut pas passer à la limite de la tumeur si la tumeur est ici faut passer au-delà ce qu'on appelle les marges saines en général ça va de 5 mm 1 cm jusqu'à 15 mm de marge saine donc vu que tu enlèves 2 cm vous allez enlever facilement 3 cm donc ça va, vous allez déborder sur le côté contralatéral et plus on l'enlève de la base de l'orgue plus on a des complications post-opératoires qui sont très importantes donc les petites tumeurs on peut les opérer mais c'est où ça se passe sur la radiothérapie alors la radiothérapie dans les tumeurs classiques sur les sujets âgés en général elle répond très mal à la radiothérapie même à la radiothérapie tout le principe mauvais de cette tumeur et lorsqu'on lit devant une tumeur en rapport avec l'atteinte virale son origine virale chez le sujet jeune là dans ce cas là la tumeur répond mieux à la radiothérapie d'accord le pronostic il est meilleur pour les aspects négatifs mais pour les aspects négatifs en général le pronostic il est mauvais parce qu'en général le pronostic souvent il est incertain et en plus il répond très mal à la radiothérapie voilà, donc si vous avez des questions et la prochaine fois on abordera la pathologie infectieuse et inflammatoire donc on a des rhinopharyngites des sinusites on verra la prochaine lecture on peut vous donner vos questions ?